

PROTOCOLO DE AGUDIZACIÓN ASMÁTICA EN UNIDAD DE OBSERVACIÓN MEDIA ESTANCIA(UOME)

SERVICIO DE URGENCIAS- HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN Agustín- Avilés

1.OBJETIVO

Manejo protocolizado de los pacientes con agudización asmática leve/moderada . subsidiarios de observación clínica, por presentar una respuesta parcial o incompleta al tratamiento inicialmente pautado, evitando un ingreso convencional y garantizando la seguridad y seguimiento durante su estancia y al alta.

2.CRITERIOS DE ADMISIÓN

2. Agudizaciones leves /moderadas (ver tabla 4.2 de evaluación de gravedad) con respuesta incompleta al tratamiento pautado en urgencias :

- Persistencia de sibilancias espiratorias o intensas.
- PEF o FEV1 =50-70%
- Frecuencia Respiratoria(FR) <30 por minuto.
- Estabilidad Hemodinámica: FC <120, TA normal
- Habla con frases cortas/ Prefiere estar sentado.
- Uso frecuente de musculatura accesoria
- No alteración del Nivel de Conciencia.
- No asocia complicaciones(Neumonía/Neumotórax) ni Comorbilidades ((I.Cardíaca)
-

3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

1.- Agudizaciones leves /moderadas que tras el tratamiento administrado en urgencias presenten:

- FR mayor de 30 rpm y uso continuo de musculatura accesoria.
- SPO2 < 90 %
- Inestabilidad hemodinámica : Hipotensión, FC >120.
- PEF o FEV1(valores de referencia) <50%
- No puede hablar bien, beber o acostarse.
- Alteración del nivel de conciencia: somnolencia,confusión.
- Tórax silencioso

- 2.- **I respiratoria grave:** Hipercapnia /acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria.
- 3.- **Enfermedad concomitante:** I cardíaca, alteraciones Electrocardiográficas que sugieran existencia patología isquémica de base..
- 4.- **Broncoespasmo 2º a otras etiologías** (broncoaspiración, cuerpo extraño..)
- 5.- **Necesidad de VMNI.**
- 6.- **Necesidad de sulfato de Magnesio y/o adrenalina como tratamiento inicial del cuadro.**
- 7.- **Riesgo alto de mala evolución (Historia**
 - Dos o más hospitalizaciones o tres o más visitas a urgencias en el último año.
 - Ingresó previo en UCI, intubación o ventilación mecánica por asma.
 - Uso frecuente o abuso de inhaladores de rescate (SABA).
 - Tratamiento con Corticoides orales (OCS) recientemente
 - No uso de ICS
 - Falta de seguimiento médico o problemas psiquiátricos/sociales que dificulten el tratamiento

4.-EVALUACIÓN INICIAL EN UOME

- **Constantes al ingreso:** Tensión Arterial(TA), frecuencia cardíaca(FC), saturación de oxígeno (sat O₂),frecuencia respiratoria (FR),temperatura(T^a).
- **Espirometría a su ingreso para tener valor de FEV1 inicial o PFE mediante medidor de Peek-flow**
- **Analítica básica:** hemograma, bioquímica (función renal, iones, glucosa).
- **Gasometría** si se registra un valor de pulsioximetría 90-92% con uso de oxígeno suplementario , ya que puede asociarse a hipercapnia.
- **Electrocardiograma** de doce derivaciones.
- **Radiografía de Tórax**(no indicada de rutina) solo si existe sospecha de complicación y/o patología concomitante.
- **Ecografía torácica clínica, (no de rutina si no seguridad en realización de la técnica)**muy útil para el diagnóstico rápido y a pie de cama de insuficiencia cardíaca descompensada,neumonía,derrame pleural y pericárdico de disfunción muscular.. mediante protocolos como el denominado Bedside Lung Ultrasonography in Emergency(BLUE)

5.TRATAMIENTO

- **Oxígeno**<40% si saturación < 92%
- **Salbutamol + ipratropio:** pMDI+cámara 4 - 8 inhalaciones c/ 4 horas.
- **Hidrocortisona** ev 100- 200 mg/6h o **metilprednisolona** 20-40 mg/8h ev o
- **Prednisona** 20-40 mg vo /12h.
- **Medidas generales** adaptadas de forma individual a cada paciente según precise.

6. MONITORIZACIÓN

- **Control constantes vitales:** FR, TA, FC, T^a, SaPO₂.
- **Medición del FEV1 o PFE** mediante Peak-Flow, previo al alta.
- **Reevaluar y vigilar** la aparición de nueva sintomatología y/o control de la existente cada 4-6h.

7. CRITERIOS DE BUENA EVOLUCIÓN

- FEV1 o PEF >60% ESTABLE
- Asintomático o mínima sintomatología.
- Sat PO₂ >95% respirando aire ambiente
- Reducción de la necesidad de medicación de rescate.

8. CRITERIOS DE MALA EVOLUCIÓN /INGRESO HOSPITALARIO

- FEV1 o PEF <60%
- Inestable
- Sintomático

9. RECOMENDACIONES AL ALTA

- Prednisona 30-50 mg 5- 7 días
- CGI y LABA (glucocorticoides inhalados + broncodilatadores agonistas beta 2 de acción prolongada).
- Antes del alta es conveniente realizar una intervención educativa mínima que incluya la comprobación de la técnica de inhalación y la administración de un plan de acción.
- Revisión por su médico de familia antes de 5 días e individualizar la necesidad de especialista en un mes según los criterios GEMA 5.3 fig2
- Incidir en hábitos de salud: abandono de tabaquismo, ejercicio físico adaptado a su patología, otros.

Tabla 4.2. Evaluación de la gravedad de la crisis de asma

	Crisis leve	Crisis moderada	Crisis grave	Crisis vital
Disnea	Leve	Moderada	Intensa	Respiración agónica, parada respiratoria
Habla	Párrafos	Frases	Palabras	Ausente
Frecuencia respiratoria (x')	Aumentada	> 20	> 25	Bradipnea, apnea
Frecuencia cardíaca (x')	< 100	> 100	> 120	Bradicardia, parada cardíaca
Presión arterial	Normal	Normal	Normal	Hipotensión
Uso musculatura accesoria	Ausente	Presente	Muy evidente	Movimiento paradójico toracoabdominal, o ausente
Sibilancias	Presentes	Presentes	Presentes	Silencio auscultatorio
Nivel de consciencia	Normal	Normal	Normal	Disminuido o coma
FEV₁ o PEF (valores referencia)	> 70 %	< 70 %	< 50 %	No procede
SaO₂	> 95 %	< 95 %	< 90 %	< 90 %
PaO₂ mm Hg	Normal	< 80 (hipoxemia)	< 60 (insuficiencia respiratoria parcial)	< 60
PaCO₂	Normal	< 40	< 40	> 45 (insuficiencia respiratoria hipercápica)

FEV₁: volumen espiratorio forzado en el primer segundo; PEF: flujo espiratorio máximo; x': por minuto; SaO₂: Saturación de oxihemoglobina; PaO₂: presión arterial de oxígeno; PaCO₂: presión arterial de anhídrido carbónico.

Fig1.

Tabla 4.5. Criterios que indican la evaluación especializada en el plazo de un mes de los pacientes tras un episodio de crisis de asma⁷¹.

- Crisis grave o vital.
- Crisis reiteradas que precisan atención en el Servicio de Urgencias^{13,16}.
- Crisis que precisan hospitalización^{16,73}. Asma grave no controlada. Sobre todo en el caso de corticodependencia, aspergilosis broncopulmonar alérgica, vasculitis.
- Gestación⁷⁴.
- Crisis desencadenada por AINE, aeroalérgenos, alérgenos alimentarios o que cursan con anafilaxia.
- Comorbilidades asociadas conocidas.
- Sospecha clínica de disfunción de cuerdas vocales, poliposis nasal, rinosinusitis, reflujo gastroesofágico, síndrome de apnea-hipopnea del sueño, síndrome de solapamiento asma/ EPOC.

AINE: antiinflamatorio no esteroideo; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Fig2

10.BIBLIOGRAFIA

- Comité Ejecutivo de la Guía Española para el Manejo del Asma (GEMA). Guía Española para el Manejo del Asma (GEMA 5.3) [Internet]. Madrid: Luzán 5; 2023 [citado 12 jun 2026]. Disponible en: <https://www.gemasma.com>
- Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention 2024 [Internet]. Fontana (WI): GINA; 2024 [citado 12 jun 2026]. Disponible en: <https://ginasthma.org>
- Plaza V, Quirce S, Delgado J, Blanco M, López-Viña A, Entrenas LM, et al. Guía Española para el Manejo del Asma (GEMA). Arch Bronconeumol. 2023;59(Supl 1):1-68
- Rodrigo GJ, Plaza V. Manejo de la exacerbación asmática en urgencias. Arch Bronconeumol. 2022;58(5):357-366.
- Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Manual de actuación en urgencias. Manejo del asma aguda en el servicio de urgencias [Internet]. Madrid: SEMES; 2023 [citado 12 jun 2026]. Disponible en: <https://www.semes.org>
- Reddel HK, Bacharier LB, Bateman ED, Brightling CE, Brusselle GG, Buhl R, et al. Global Initiative for Asthma Strategy 2024: executive summary and rationale for key changes. Eur Respir J. 2024;63(1):2302730.
- British Thoracic Society; Scottish Intercollegiate Guidelines Network. British guideline on the management of asthma [Internet]. London: BTS/SIGN; 2024 [citado 12 jun 2026]. Disponible en: <https://www.brit-thoracic.org.uk>
- National Asthma Education and Prevention Program Coordinating Committee. 2020 Focused Updates to the Asthma Management Guidelines. J Allergy Clin Immunol. 2020;146(6):1217-127

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE:

EPOC/ASMA

En aquellas patologías respiratorias susceptibles de observación debemos vigilar especialmente los signos de **dificultad respiratoria y empeoramiento del intercambio gaseoso**.

Signos y síntomas a vigilar y registrar

- **Estado respiratorio**
 - ♣ Disnea progresiva
 - ♣ Ortopnea (dificultad respiratoria al acostarse).
 - ♣ Disnea paroxística nocturna.
 - ♣ Taquipnea.
 - ♣ Saturación de oxígeno baja.
 - ♣ Trabajo respiratorio: uso de musculatura accesorio, tiraje intercostal o supraclavicular, bamboleo abdominal.
 - ♣ Ruidos audibles. Sibilancias intensas.
 - ♣ Dificultad para hablar
 - ♣ Aparición de criterios de compromiso de vía aérea superior: estridor.
- **Estado neurológico**
 - ♣ Confusión.
 - ♣ Agitación.
 - ♣ Somnolencia por hipoxia.
- **Tos:**
 - ♣ Frecuencia. Persistente
- **Perfusión tisular**
 - ♣ Cianosis (labios o uñas azuladas).
- **Estado cardiovascular**
 - ♣ Taquicardia

Registros Específicos en la Historia Clínica

- Monitorización de signos vitales.
- Monitorización cardíaca y saturación de oxígeno.
- Vigilar respuesta al tratamiento (inhaladores).

Signos de alarma

Avisar inmediatamente si aparece:

- Disnea intensa o súbita.
- Saturación muy baja.
- Taquicardia.
- Alteración del nivel de conciencia.
- Necesidad de medicación de rescate

BIBLIOGRAFÍA:

1. - Ferrer Tarrés JM, Prat Marín A, Tomás Vecina S. Revisión de la utilización de las áreas de observación de urgencias hospitalarias. Med Clin (Barc). 2007;128(6):224-31. Quirónsalud.
2. - Inhaladores de cartucho presurizado: técnica de inhalación. Escuela de Pacientes Neumología. Madrid: Quirónsalud; 2023. Disponible en: <https://www.quironsalud.com> [Acceso 04 sept 2026]. Servicio Andaluz de Salud.
3. - Guía de diseño y organización de servicios de urgencias hospitalarias. Sevilla: Consejería de Salud; 2016. Soler Gómez Y, Fernández Viñado DM, Martínez Fernández C, et al.
4. - Atención de enfermería al paciente politraumatizado por accidente de tráfico: enfoque integral en la emergencia. Rev Sanitaria Invest. 2025;6(7):e2660-7085. Sánchez Reyes E, Pinal Moreno E, Ortega Vargas MC.
5. - Guía clínica de enfermería del enfermo con insuficiencia cardíaca. Rev Enferm IMSS. 2004;12(3):155-62. Grupo de Trabajo de EPOC SEMERGEN.

6. - Protocolo de manejo del paciente con EPOC agudizado en urgencias. SEMERGEN. 2020;46(Supl 1):1-12. Gómez Martínez A, González Vallejo ML, García Cuesta P.
7. - Plan de cuidados enfermeros en el paciente con EPOC y neumonía según taxonomía NANDA-NIC-NOC. Rev Enferm CyL. 2018;10(2):45-58. Gobierno de Canarias.
8. - Guía de atención a emergencias sanitarias en los centros educativos: Traumatismos II. Las Palmas: Consejería de Educación; 2021.Universidad de Salamanca.
9. - Guía docente Enfermería en Urgencia y Riesgo Vital. Grado en Enfermería. Ávila: USAL; 2024-2025.Mayo Clinic.
10. - Inhaladores para el asma: ¿cuál es el indicado para usted? Rochester: Mayo Foundation; 2024. Disponible en: <https://www.mayoclinic.org> [Acceso 04 sept 2026].
11. - Guía de actuación en urgencias de la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias (SEEUE)
12. - Cuidados de enfermería en el paciente crítico en urgencias de García González, M., et al. (2020)
13. - Manejo del paciente con dolor torácico en urgencias de López López, J., et al. (2019)
14. - Emergencias (revista de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias)
15. - Enfermería de Urgencias (revista especializada en cuidados de enfermería en urgencias)
16. - SEMES (Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias) - Guías y protocolos
17. - SEEUE (Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias) - Recursos y documentos